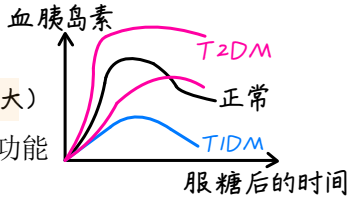
产生一个内源胰岛素就释放一分子C肽

（四）胰岛β细胞功能检查（均不能诊断糖尿病）

（1）**C肽/胰岛素释放试验：鉴别T1DM和T2DM**

	血浆C肽/胰岛素水平	C肽/胰岛素释放曲线
T1DM	↓	低平
T2DM	较高、正常、较低 代偿	高峰延迟 胰岛素抵抗，敏感性↓



（2）静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验、高糖钳夹试验：反映胰岛素释放的第一时相

胰岛素释放第Ⅰ时相（快速分泌阶段）：储存在β细胞当中的胰岛素释放（快速但储存量不大）

（3）胰高血糖素-C肽刺激试验、精氨酸-C肽刺激试验：反映**非葡萄糖**介导的胰岛素释放功能

六、治疗

症状较轻的胖胖可以先进行饮食运动疗法

糖尿病综合管理的“五架马车”：①糖尿病教育 ttsx；②医学营养治疗；③运动治疗；④病情监测；⑤药物治疗⭐

（一）药物概述

（1）注射制剂：胰岛素及其类似物、GLP-1受体激动剂（肽）

胰高血糖素样肽→胰岛素↑（前馈）

小肠
GIP 抑胃肽
GLP 胰高血糖素样肽 → 血糖升高前促胰岛素↑（前馈）
（肠促胰素）

（2）口服制剂：

双胍类	二甲双胍 本身可以增敏胰岛素
α-糖苷酶抑制剂	波糖 作用时间长 促进早时相胰岛素释放（针对餐后血糖）
传统的促胰岛素分泌剂	磺酰脲类（格列XX）、格列奈类 作用于β细胞ATP敏感的钾通道（不依赖G）
PPAR激活剂	噻唑烷二酮类（格列酮）、西格列他钠
SGLT-2抑制剂	格列净 抑制近端小管重吸收G
DPP-4抑制剂	格列汀 打屁屁就听话
葡萄糖激酶激活剂GKA	多格列艾汀

G —乙糖激酶→ G-6-P → 糖酵解
葡萄糖激酶（乙糖激酶的同工酶）（促进G代谢，降血糖）
（肝、胰岛β细胞）

